



Capítulo 10: Identidades de Género y Disidencias en la Clínica

Más allá del prisma

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA PROFESIONALES DE LA SALUD MENTAL

CAPÍTULO 10

IDENTIDADES DE GÉNERO Y DISIDENCIAS EN LA CLÍNICA

Introducción: El fin de los binarismos normativos y la urgencia de una escucha despatologizada

El imperativo de revisión teórica

La práctica clínica contemporánea se encuentra interpelada por una profunda mutación en las coordenadas del género, la sexuación y la identidad. Si durante décadas el psicoanálisis ortodoxo operó bajo el mandato de un binarismo estricto —donde la anatomía biológica determinaba de manera lineal el psiquismo y donde cualquier disidencia respecto al dimorfismo sexual hegemónico era rotulada mecánicamente como una patología, una perversión o una detención en el desarrollo psicosexual—, la clínica actual exige una revisión radical de estos fundamentos teóricos.

- ❏ La emergencia de las identidades trans, no binarias, género fluido y las diversas disidencias sexuales no representa una "desviación" a ser corregida, sino la manifestación legítima de la plasticidad subjetiva y corporal frente a los mandatos identificatorios tradicionales.

El modelo de la Clínica de la Convergencia

Desde el modelo de la Clínica de la Convergencia, abordar las identidades de género y las disidencias no implica ceder ante un eclecticismo acrítico ni abandonar la metapsicología, sino articular la rigurosidad de la teoría del sujeto con los aportes contemporáneos de la neurobiología del esquema corporal, la endocrinología y los estudios de género despatologizadores.

La tarea del analista no es dictaminar la "verdad" de un cuerpo según los cánones de la naturaleza instituida, sino acompañar al sujeto en la construcción singular de su imagen corporal y en la tramitación de su goce, restituyendo la palabra allí donde el mandato cultural y la violencia social han intentado silenciar la diferencia.

Metapsicología del Esquema Corporal, la Imagen y los Mandatos Identificatorios

Para comprender con rigor metapsicológico la experiencia de las personas trans y no binarias, es menester desbrozar la diferencia radical que existe entre la anatomía biológica, el cuerpo como vivencia psíquica (imagen corporal) y los mandatos identificatorios que la cultura impone al sujeto desde antes de su nacimiento.

Anatomía biológica

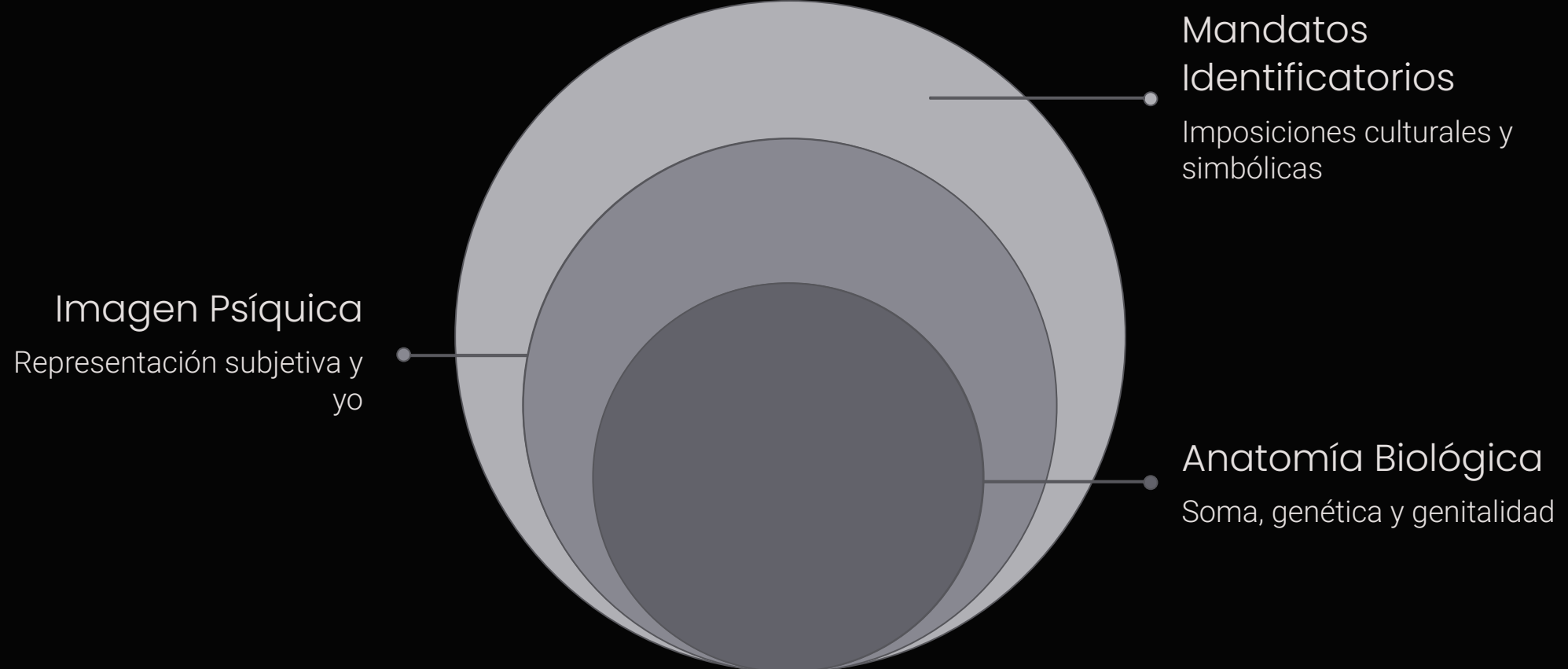
El cuerpo inscripto por la genética, los genitales y los caracteres sexuales secundarios determinados por la biología.

Imagen corporal

El cuerpo como vivencia psíquica: la representación subjetiva e interna que el yo construye de su propia corporalidad.

Mandatos identificatorios

Las exigencias culturales y simbólicas que la familia y la sociedad imponen al sujeto desde antes de su nacimiento, estructurando el género esperado.



El estadio del espejo y la fractura entre el soma y la imagen

El fundamento freudo-lacaniano

Freud advirtió tempranamente que el yo es, ante todo, una entidad corporal: es, en su raíz, la proyección de una superficie corporal. Posteriormente, Jacques Lacan formalizó en el estadio del espejo cómo el cachorro humano, inmerso en el desamparo motor originario, unifica su vivencia corporal fragmentada a través de la asunción de la imago especular, mediada por la mirada y el deseo del Otro parental.

La discordancia en las vivencias trans y disidentes

- En las vivencias trans y disidentes, se produce una discordancia radical y dolorosa entre el **soma** (el cuerpo biológico inscripto por la genética y los genitales con los que se nace) y el sentido de la **imagen yoica** que reclama el psiquismo para habitarse sin la angustia de la disociación.
- Esta discordancia no constituye una "alucinación" ni un delirio psicótico, como postulaba la psiquiatría clásica. Es una **verdad subjetiva ineludible**: el cuerpo biológico se experimenta como un error o un traje ajeno que asfixia al yo, generando un sufrimiento comparable al estrangulamiento psíquico.

Freud: el yo como superficie corporal

El yo no es una instancia puramente abstracta; su raíz es la proyección psíquica de la superficie del cuerpo vivido.

Lacan: la imago especular y el Otro

La unificación de la imagen corporal fragmentada se produce a través del espejo, mediada por la mirada y el deseo del Otro parental.

La fractura trans: soma vs. imagen yoica

La discordancia entre el cuerpo biológico y la imagen psíquica no es patología psicótica, sino verdad subjetiva que genera sufrimiento real e ineludible.

La deconstrucción de los mandatos identificatorios del Superyó cultural

Los mandatos identificatorios parentales y sociales que el Superyó transmite de generación en generación exigen una correspondencia unívoca:

Varón con pene

→ Masculino → Heterosexual

Mujer con vulva

→ Femenino → Heterosexual

La colisión psíquica con la norma

Cuando el sujeto experimenta que su verdad deseante y su identidad corporal no coinciden con esta grilla preestablecida, el aparato psíquico entra en una **colisión violenta** con las exigencias normativas de la cultura. El Superyó cultural opera como un agente culpabilizador que sanciona la diferencia y exige la conformidad.

La tarea metapsicológica de la clínica

La tarea metapsicológica de la clínica no es someter al paciente al Procrustes de la norma estadística, sino **analizar cómo operan esas identificaciones alienantes** para permitir que el sujeto rompa con el mandato superyoico culpabilizador y construya una autoría propia sobre su cuerpo, su nombre y su deseo.

📄 El objetivo clínico es restituir la palabra y la autoría subjetiva allí donde el mandato cultural y la violencia social han intentado silenciar la diferencia.

Neurobiología de la Imagen Corporal y la Disforia: Plasticidad Cerebral y Sensopercepción

La metapsicología de la imagen corporal y el sufrimiento identitario encuentra un correlato científico de extraordinaria precisión en las neurociencias afectivas y en el estudio de la plasticidad del esquema corporal en el sistema nervioso central.



Neuroimagen funcional

Los estudios contemporáneos en neuroimagen funcional documentan desacoples persistentes en las redes cerebrales de autoevaluación corporal en personas con incongruencia de género.



Plasticidad sináptica

El sistema nervioso central construye mapas dinámicos y multisensoriales de la corporalidad que pueden reconfigurarse ante procesos de afirmación de género.



Estrés alostático

La disonancia neurosomática genera activación crónica en los circuitos de la ínsula anterior, sumergiendo al sistema nervioso en un estado de estrés alostático sostenido.

La articulación entre metapsicología y neurobiología no es un eclecticismo acrítico: es la condición de posibilidad de una clínica rigurosa y despatologizadora que honre la complejidad del sujeto.

El mapa cerebral del cuerpo y el sentido de propiedad somática

La construcción dinámica del esquema corporal

El cerebro humano no posee una representación estática ni puramente genética del cuerpo; construye un **mapa dinámico y multisensorial** de la corporalidad —albergado en la corteza somatosensorial, la ínsula y el lóbulo parietal— que integra constantemente información propioceptiva, táctil, visual y vestibular.

La disonancia neurosomática

En las personas con incongruencia de género o disforia, los estudios contemporáneos en neuroimagen funcional sugieren que las redes cerebrales encargadas de autoevaluar la pertenencia del propio cuerpo (el sentido de *agency* y *ownership* corporal) experimentan un **desacople persistente** entre la autoimagen neurológica innata y los caracteres sexuales secundarios del soma biológico.

Estructuras neurales implicadas

- **Corteza somatosensorial:** representación topográfica del cuerpo
- **Ínsula anterior:** integración interoceptiva y dolor visceral
- **Lóbulo parietal:** sentido de agency y ownership corporal

El estrés alostático sostenido

Este desacople no es una "fantasía caprichosa"; genera una **activación crónica en los circuitos de la ínsula anterior** (asociada al dolor y a la incomodidad visceral), sumergiendo al sistema nervioso en un estado de estrés alostático sostenido con consecuencias sistémicas documentadas.

La modulación neurobiológica de la transición

Cuando un sujeto accede a procesos de afirmación de género —ya sea mediante la modificación hormonal (terapias de reemplazo hormonal) o cirugías de afirmación corporal—, la neurobiología documenta un fenómeno notable de **plasticidad y reconfiguración sináptica**:

1

Alineación soma–imagen

Al alinear la materialidad del soma con la imagen corporal interna, disminuye drásticamente la hiperactivación amigdalina y el estrés crónico del Eje HPA.

2

Liberación de recursos metabólicos

El cerebro deja de gastar una enorme cantidad de energía metabólica en el esfuerzo defensivo de sostener una disociación insoportable.

3

Integración identitaria genuina

La corteza prefrontal recupera su funcionamiento óptimo y el sujeto experimenta, por primera vez, una calma somática y una integración identitaria genuina.

Implicancias clínicas

La evidencia neurobiológica sobre los efectos de la afirmación de género no es un argumento periférico: es la base científica que fundamenta la posición despatologizadora de la Clínica de la Convergencia. Acompañar al sujeto en su proceso de afirmación es, literalmente, restituir el funcionamiento óptimo del sistema nervioso central.

Articulación metapsicología–neurobiología

La reducción del estrés alostático, la recuperación de la función prefrontal y la integración somática documentadas por la neurobiología son el correlato científico de lo que la metapsicología describe como la tramitación del goce y la construcción de una imagen corporal habitable. Ambos registros se iluminan mutuamente.